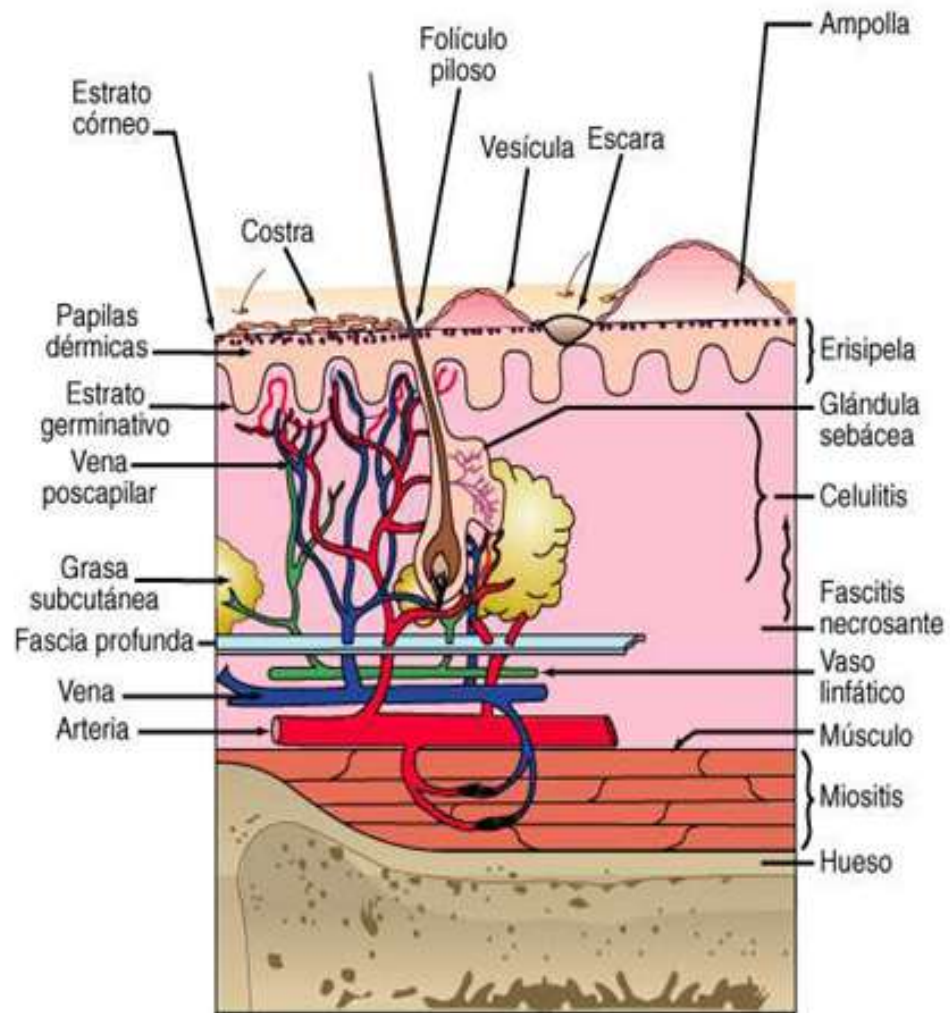

INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS

Dra. Macarena Perez
Residente de 2do año Infectología del HTJS



ERISPELA: DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

- Infección aguda que compromete la dermis superficial y vasos linfáticos subyacentes.
- **Placa edematosa, caliente de bordes netos no sobreelevada,** eritematosa, eritemato purpúrica, ampollar o a veces necrótica. Adenopatía regional.
- Más frecuente en MMII. También en la cara pero en menor frecuencia.
- **Etiología: S. Pyogenes y estafilococos principalmente.**
- Fisiopatología: colonización de la piel + disrupción de la barrera mecánica (trauma, intertrigo, onicomycosis).
- FR: obesidad, insuf. venosa, DBT, enolismo (OH), cirrosis.

ERISPELA: CLÍNICA Y DX

- Clínicamente puede presentarse con hipertermia, taquicardia y en casos severos asociar confusión e hipotensión (además de la lesión de piel):
GRAVE con criterio de internación.
- **Laboratorio: leucocitosis, VSG acelerada y PCR aumentada.**
- No son necesarios los estudios complementarios. EL DX ES CLÍNICO.
- Los hemocultivos son positivos en menos de 5% de los casos por lo que **NO ESTÁN INDICADOS excepto en cuadro invasivos** por *S. Pyogenes*.



CELULITIS: DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

- Infección aguda que compromete el TCS.
- **SIN LÍMITES NETOS (diferencia con erisipela).**
- **Etiología: S. pyogenes y S. aureus.** Dependiendo de la puerta de entrada puede modificarse el patógeno (ej. mordeduras, ADIV aumenta el riesgo de BGN)
- FR: disrupción de la barrera, DBT, Obesidad (OBS), edemas crónicos, OH, Inmunosuprimidos, Adictos a drogas endovenosas (ADIV), picaduras, mordeduras)
- Según localización aumenta su gravedad: celulitis orbitaria vs. periorbitaria.

CELULITIS: CLÍNICA Y DX

- Inicio brusco, presencia de edema, eritema, aumento de temperatura, dolor y límites poco definidos.
- Síntomas sistémicos: fiebre, escalofríos. Shock infrecuente.
- Dx: Clínico.
- Rx en sospecha de infección Necrotizante: presencia de gas. Ecografía y TAC: sospecha de colecciones
- **HC** son + en 2-5% de los casos. No son útiles de rutina en pacientes inmunocompetentes. **Están indicados en inmunocomprometidos, mayores de 65 años, signos de gravedad y shock.**
- Cultivos por punción bajo r  dito. Solo indicada en IC, presentaci  n at  pica, g  rmenes at  picos, cuadros severos.

CELULITIS: TRATAMIENTO

Criterios de internación:

- Gravedad del cuadro (hipoTA, compromiso del estado general, fallo renal, acidosis, leucocitosis con formas inmaduras)
- Factores locales (heridas penetrantes, posibilidad de gérmenes infrecuentes, dudas diagnósticas con la presencia de colecciones o inf. necrotizantes)
- Comorbilidades: DBT, inmunosupresión, obesidad

VIGILANCIA de la RESISTENCIA a los ANTIMICROBIANOS Red WHONET Argentina Tendencias 2013-2024 parcial

Servicio Antimicrobianos

Laboratorio Nacional y Regional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos - OPS

Centro Colaborador de OMS en Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos

Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas

ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"



Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas
"Dr. Carlos G. Malbrán"



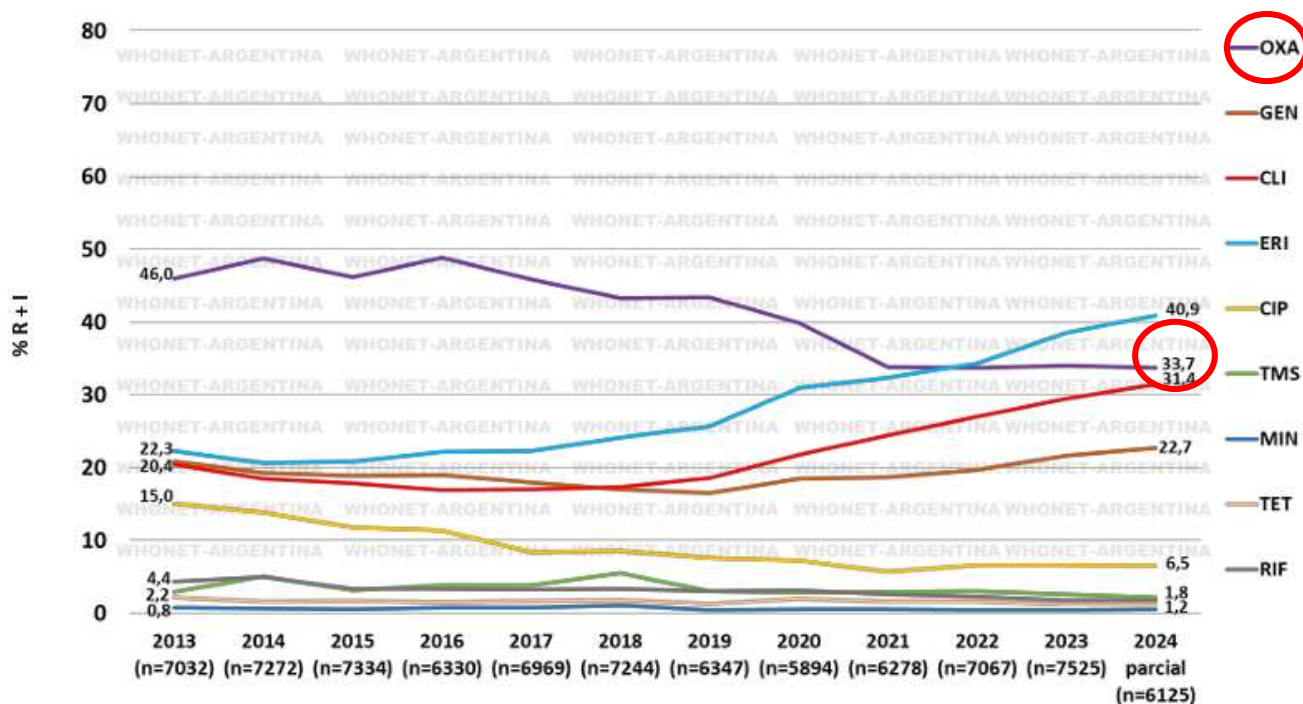
ANLIS
MALBRÁN
INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS
MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Staphylococcus aureus

Global (MRSA+MSSA)

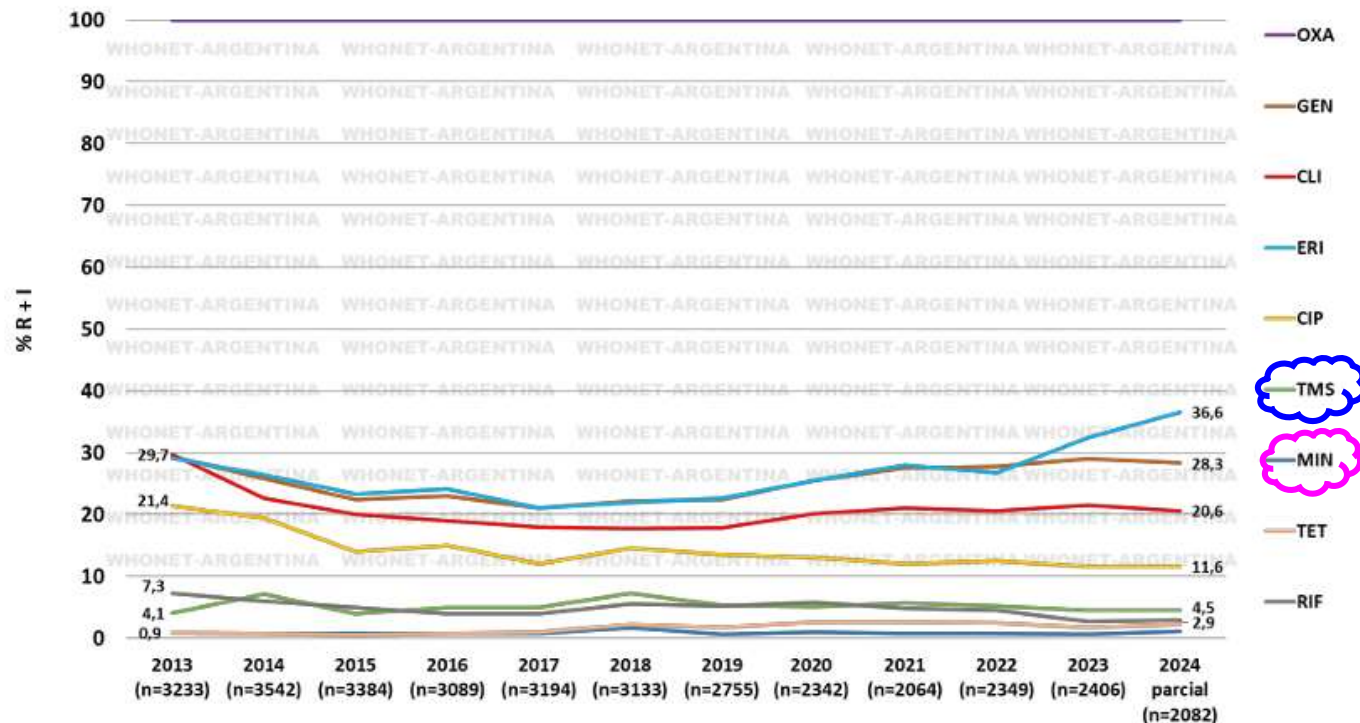
n= 81.417



Staphylococcus aureus

Meticilino Resistente Global

n= 33.573



CELULITIS Y ERISPELA: TRATAMIENTO

- Cobertura para *S. pyogenes* y *S. aureus*
- Según el estado clínico del paciente se utilizara VO o EV
- **Cefalexina 500 mg cada 6 hs, Cefalotina 1 g cada 4-6 hs EV, TMS FORTE 1 comp cada 12 hs o Minociclina 100 mg cada 12 hs VO** (mala evolución con tratamiento ATB, sospecha de colonización por SAMR)
- **Casos graves: Vancomicina 15-20 mg/kg cada 12-8 hs** (también en alérgicos o fallas de tratamiento antibiótico y signos de gravedad) y se agrega Clindamicina 600 mg cada 6 hs como inmunomodulador.
- **Duración de 7-14 días**
- Elevación del miembro afectado. Tratamiento de la puerta de entrada para evitar recidivas









CELULITIS



ERISPELA



IMPÉTIGO: DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

- Piodermitis superficial que afecta la epidermis y cura SIN cicatriz.
- Fisiopatología: colonización de la piel- puerta de entrada- lesión que se rompe el líquido se deseca y forma costras melicéricas
- **Etiología: S. Pyogenes, S. Aureus**
- Tipos ampollar (siempre S. Aureus por toxina) y no ampollar (Pyogenes y Aureus, 70%)
- Altamente transmisible, por contacto directo

IMPÉTIGO: CLÍNICA Y DX

- Se encuentra principalmente en zonas expuestas (cara y extremidades)
- No ampollar es el más frecuente. Ampollas epidérmicas que no se ven y que rápidamente se rompen y se cubren de costras.
- Autoinoculación.
- Ampollar: producido por las toxinas exfoliativas A y B del *S. aureus* (Sme. de la piel escaldada localizado). Sin tratamiento puede complicarse.
- Dx: Clínico
- No es útil la determinación de ASTO.

IMPÉTIGO: TRATAMIENTO

- Cobertura principalmente de *S. aureus*.
- **Tratamiento tópico: Ac. fusídico, mupirocina** (3 veces por día por 7 días, similar al tto sistémico). En áreas limitadas, tipo no bulloso.
- Tratamiento sistémico: Cefalosporinas de 1ra generación, Amoxi-Clavulánico. Mayor superficie corporal o síntomas sistémicos.





FORUNCULOSIS: DEFINICIÓN

- Forúnculo: Infección aguda del folículo piloso en su parte más profunda con perifoliculitis. Desorganiza la dermis y cura con cicatriz. Nódulo que se origina de una foliculitis y que tiene la tendencia de drenar al exterior.
- Forunculosis: aparición repetida o simultánea de varios forúnculos.
- **Etiología: S. Aureus**

FORUNCULOSIS: CLÍNICA

- Comienza como un nódulo inflamatorio, rojo y doloroso centrado por el orificio de un folículo piloso. Luego de unos días se absceda, evoluciona con necrosis central, drena y cura con cicatriz

FR

- Locales: zonas pilosas y de roce, oclusión y transpiración; disrupciones de la barrera cutánea por rascado; transpiración excesiva y falta de higiene.
- Generales: obesidad, defectos en la función de los neutrófilos, tto con corticoides, inmunosupresión, DBT

FORUNCULOSIS: TRATAMIENTO

- Lesiones pequeñas: tratamiento local (agua y jabón y eventualmente calor húmedo)
- Lesiones de mayor tamaño: eventual drenaje quirúrgico.
- El tratamiento sistémico no suele ser necesario a menos que haya celulitis circundante o compromiso sistémico.
- Cefalosporina de 1ra generación
- Colonización: tto tópico con mupirocina nasal cada 12 hs los primeros 5 días de cada mes.

FORÚNCULO



ANTRAX

IPPB

LEVE

GRAVE

Internación

SIN FR SAMR

CON FR SAMR

**CEFALEXINA 1 g
C/12 hs 7-14 d**

**MINOCICLINA
100 mg C/12 hs**

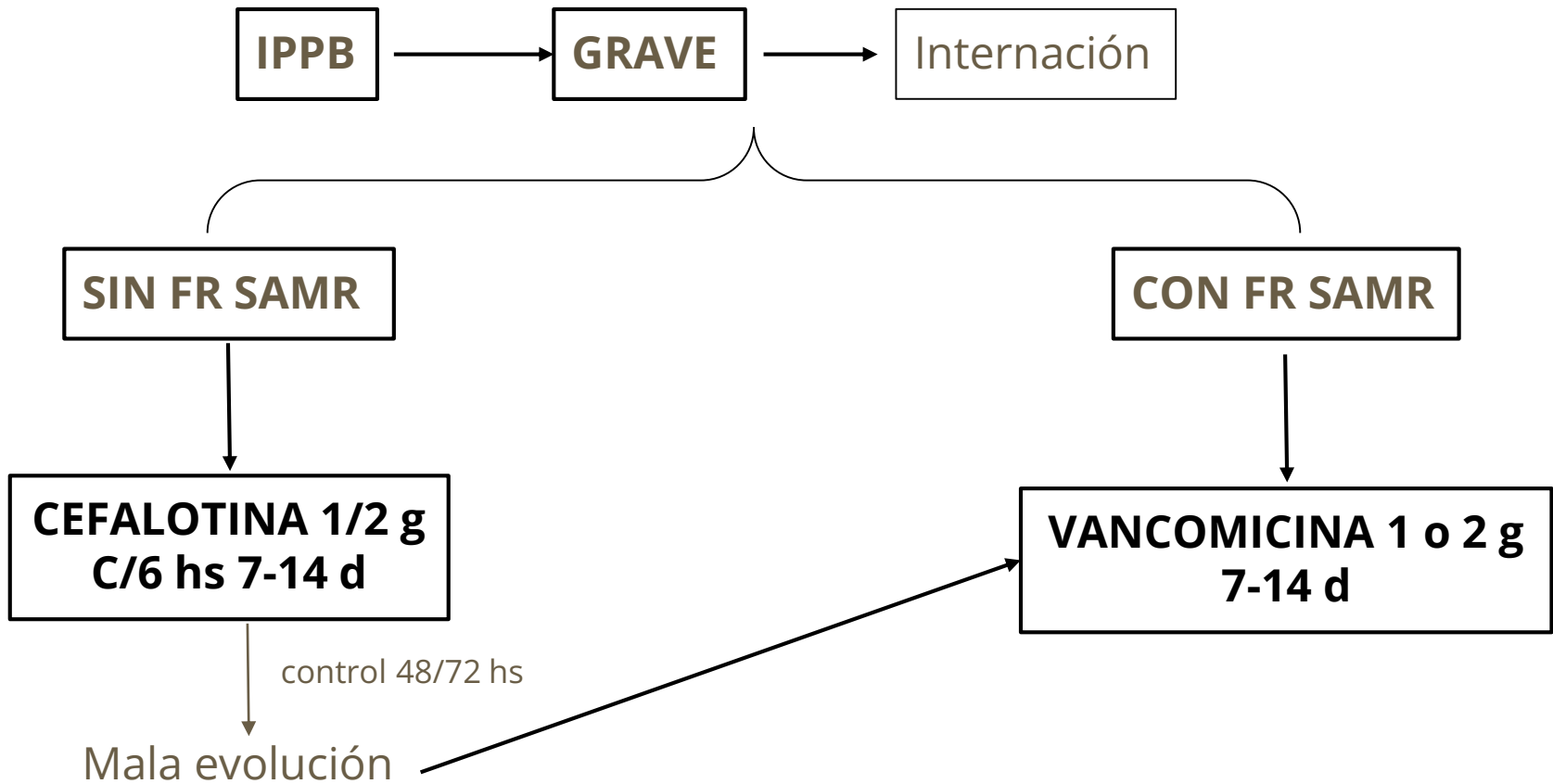
**TMS FORTE 1
comp C/12 hs**

control 48/72 hs

Mala evolución

7-14 días





INFECCIONES NECROTIZANTES

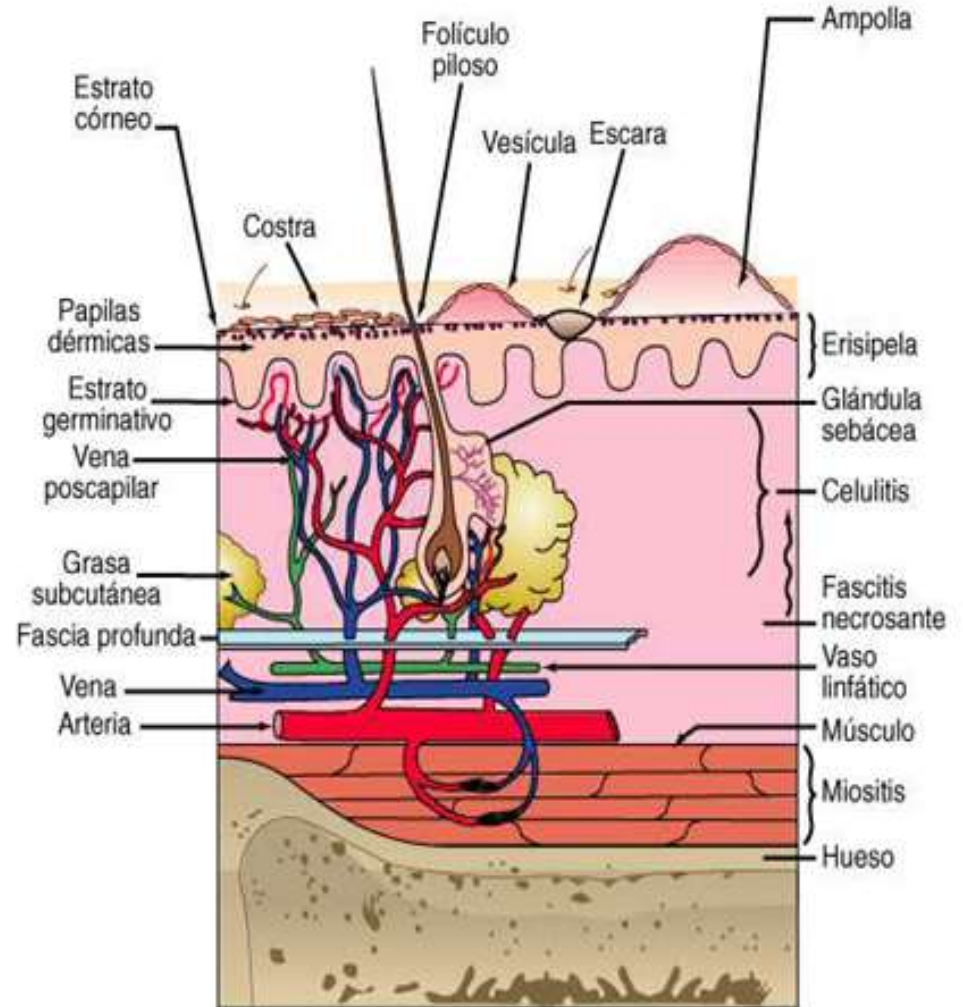
- Infecciones graves con elevada morbimortalidad que requieren **tratamiento quirúrgico y antibiótico de amplio espectro empírico precoz.**

Celulitis necrotizante: compromete piel y TCS (fascia superficial) sin alcanzar la fascia muscular. Proceso rápidamente progresivo con necrosis extensa.

Fascitis necrotizante (FN): compromete fascia superficial y muscular.

Mionecrosis: compromete la masa muscular. Proceso agudo sumamente tóxico, de progresión rápida y potencialmente fatal.

Tratamiento similar entre todas. **Lo importante es diferenciar precozmente las infecciones graves que requieren tratamiento quirúrgico y ATB, de un cuadro no grave que con drenaje y ATB presenta buena evolución.**



INFECCIONES NECROTIZANTES: ETIOLOGÍA

- Inmunocompetentes: *S. pyogenes* y *S. aureus*.
- Los procesos necrotizantes pueden ser mono o polimicrobianos.
- **Procesos monomicrobianos:** mediado por toxinas (FN por *S. pyogenes*, FN por *S. aureus*, mionecrosis clostridial)
- **Procesos polimicrobianos:** sinergismo entre aerobios y anaerobios.

Aerobios: enterobacterias, Streptococcus grupo A y S. aureus.

Anaerobios: Peptostreptococcus sp, grupo Bacteroides fragilis, Prevotella sp, Porphyromonas spp y Clostridium sp.

INFECCIONES NECROTIZANTES: FR

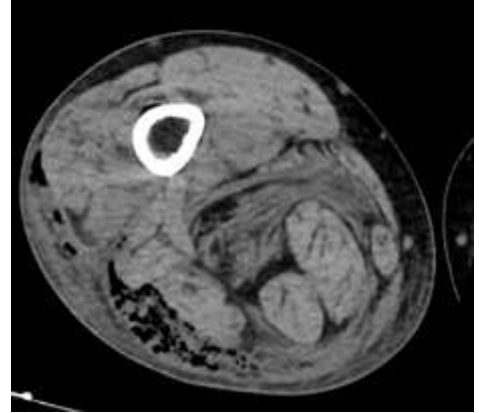
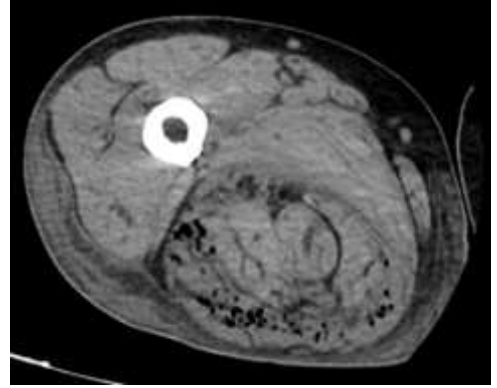
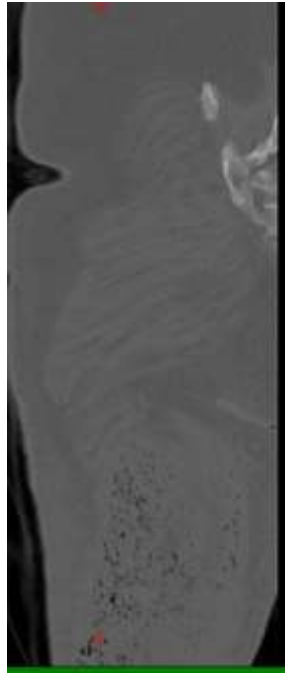
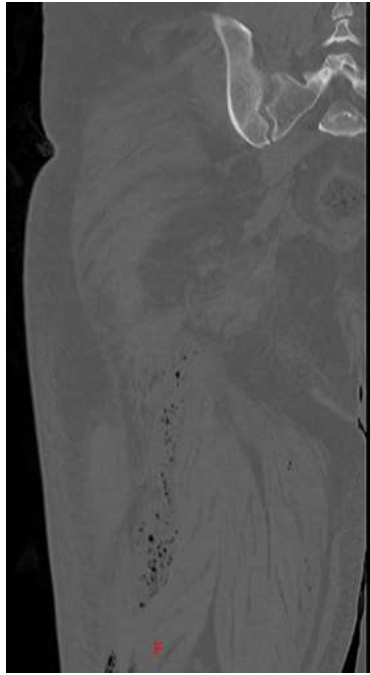
- Traumas penetrantes, fracturas, inyectables.
- Lesiones de mucosa rectal, uretral, vaginal o gastrointestinal por procedimientos externos o cirugías.
- DBT con enfermedad vascular periférica, neutropenia.

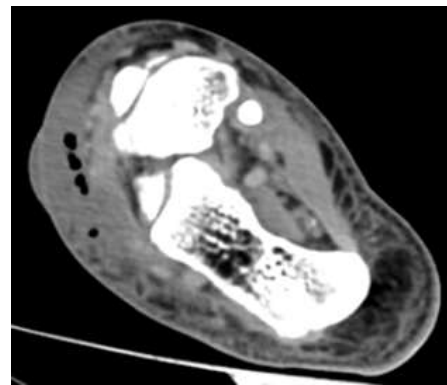
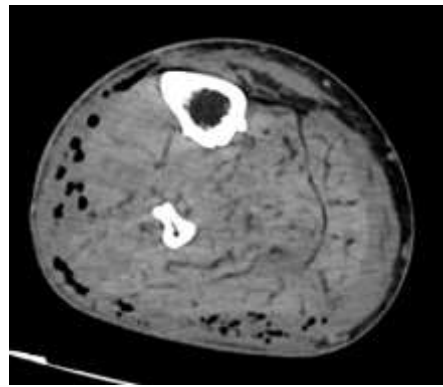
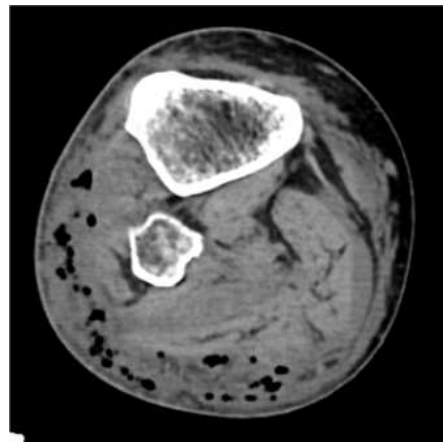
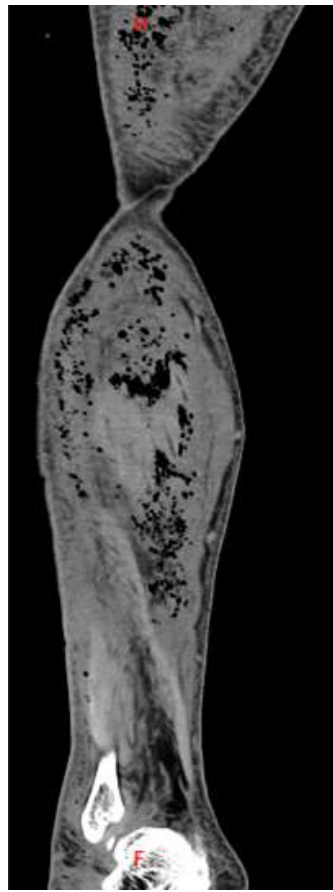
INFECCIONES NECROTIZANTES: DX

CLÍNICA

- Edema, eritema o palidez, fiebre, dolor intenso desproporcionado, sensibilidad, necrosis de la piel.
- Es difícil discernir entre un proceso grave y una celulitis. Debe sospecharse en pacientes cuyo estado se deteriora rápidamente.
- Equimosis, crepitación, anestesia cutánea.
- El diagnóstico definitivo es quirúrgico. La sospecha es clínica.







INFECCIONES NECROTIZANTES: DIAGNÓSTICO

LABORATORIO: sugieren mal pronóstico

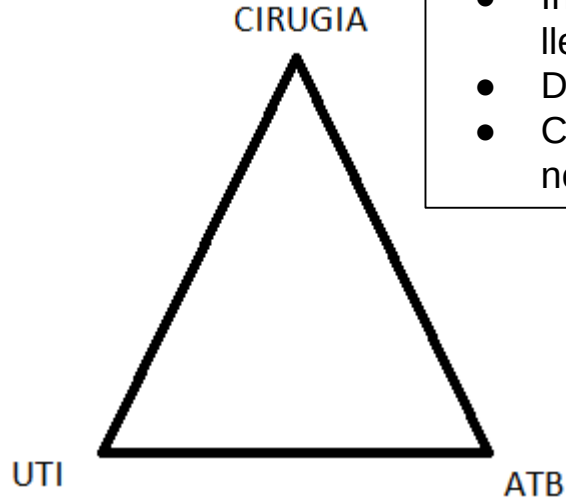
- GB ($> 15000/\text{mm}^3$)
- Hiponatremia ($< 135 \text{ mEq/l}$)
- Lactato ($> 6 \text{ mmol/l}$)
- PCR aumentada
- Creatinina aumentada

INFECCIONES NECROTIZANTES: DIAGNÓSTICO

IMÁGENES: **no debe retrasar la intervención quirúrgica.** Cuando hay dudas

- Rx Simple: presencia de gas
- TAC con contraste muestra precipitación de la fascia
- RNM mayor intensidad de señal en T2 y áreas de intensidad de señal anormal en la fascia profunda
- **El diagnóstico definitivo se realiza en el acto quirúrgico donde se evidencia hasta dónde ha avanzado la infección**

INFECCIONES NECROTIZANTES: TRATAMIENTO

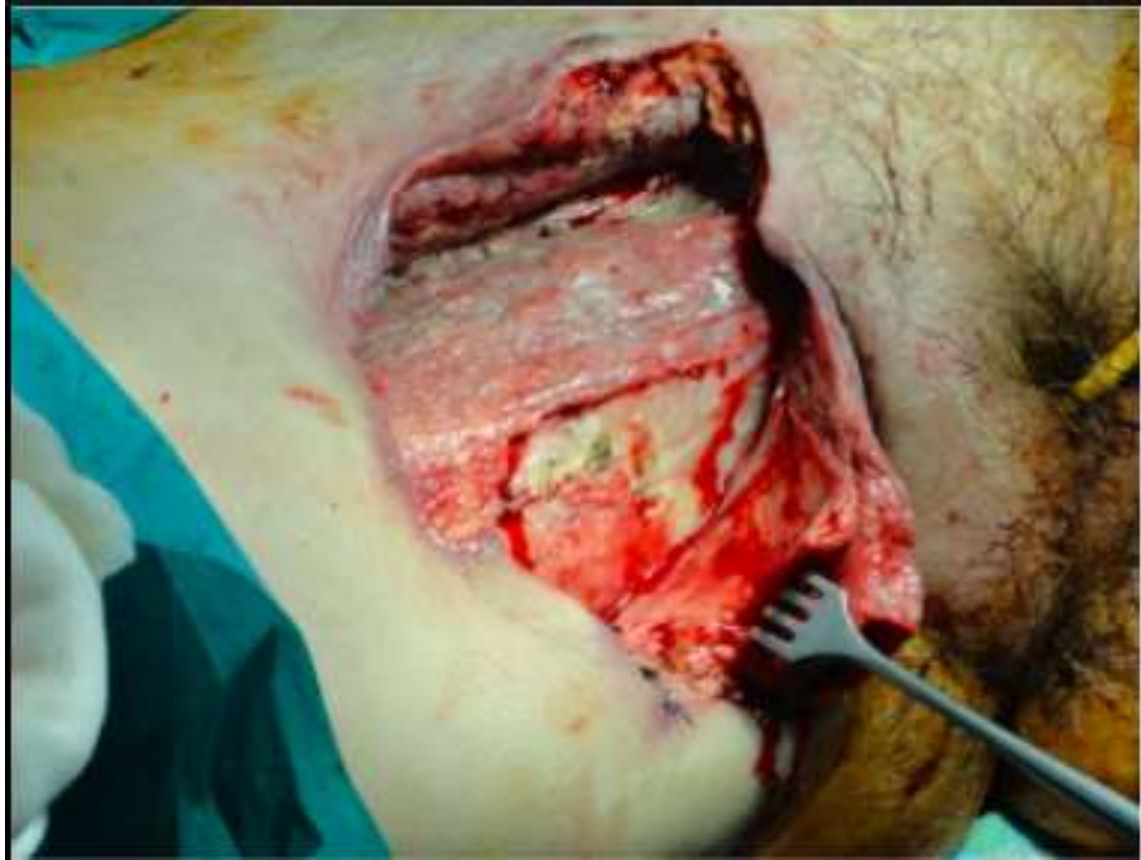


- La mortalidad disminuye si se realiza la intervención dentro de las 24 hs del Dx
- Intervención precoz y suficiente hasta llegar al tejido vital
- Dejar herida abierta
- Control diario: repetir hasta que no haya necrosis

- Cobertura de amplio espectro que cubra Cocos Gram + (MS y MR), BGN y anaerobios
- Agregar Clindamicina como antitoxina
- PTZ+VANCO+CLINDA



SIN CIRUGÍA LA
MORTALIDAD ES DEL
100%



Gracias por su atención